07

S.P 3750

30

الفحص المفصلي المُفصَّل

د. مهند أبو كرشة

14/10/2024

مدقق

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

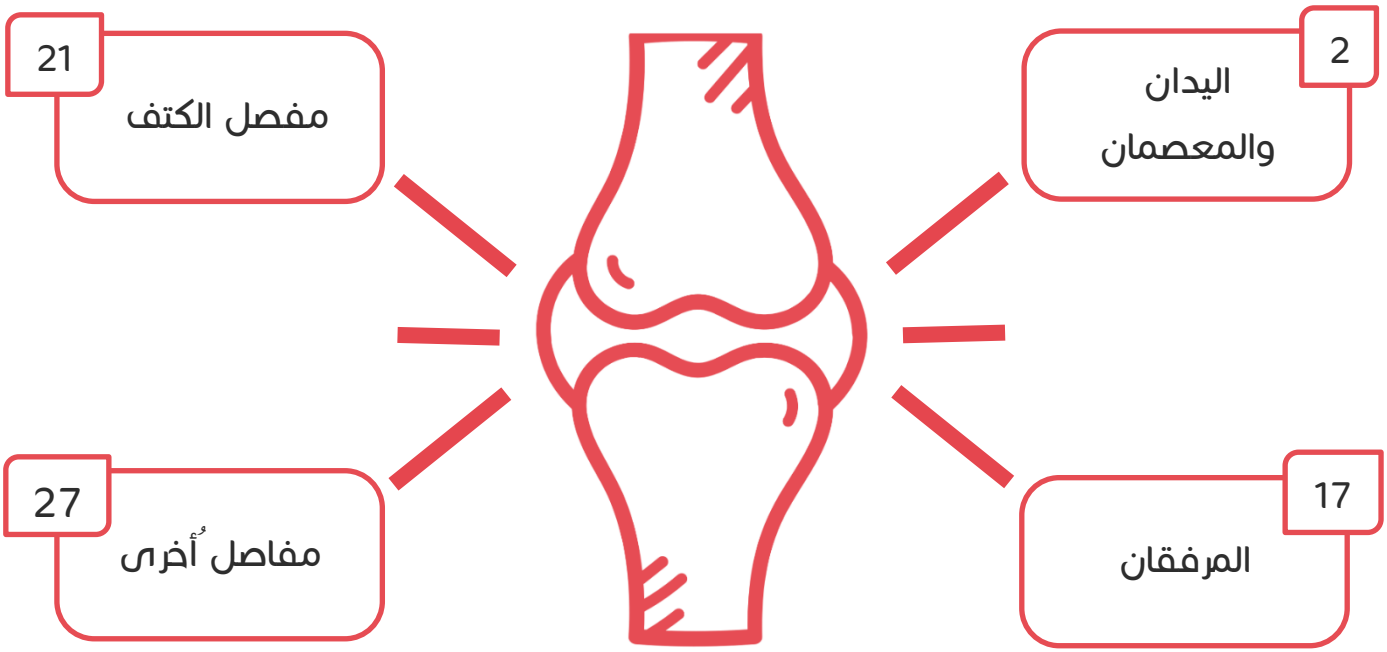
RBC Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

أصدقاءنا الأعزاء..

نكمل معكم رحلتنا في مادة المهارات السريرية مع المحاضرة الثانية من قسم الرثوية، وبعد أنّ تحدثنا عن كيفية الفحص السريري العام لمريض المفاصل، سنتعلم في هذه المحاضرة طُرق فحص خاصة بمفاصل الطرف العلوي وأُخرى غيرها ونفصّل بها ونتمنى أن نكون قد وفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل..





اليدان والمعصمان

مُقدمة

- سنكتشف في المستقبل أن اليد مِرآة للعديد من الأمراض الداخلية سواءً في الفحص السريري (بتبدلاتها الجلدية أو الظفرية أو تبدلات لب الأصابع) أو في الفحص الشعاعي.
- في فحص اليدين يجب فحص كلا الوجهين (الظهري والراحي).
- يوجد في كل يد العديد من المجموعات المفصلية والتي تُفحَص من الوجه الظهري:

المعصم	المفصل الرسغي السنعي الأول	المفاصل السنعية السلامية MCP	المفاصل بين السلامية الدانية PIP	المفاصل بين السلامية القاصية DIP

تذكرة تشريحية

- يتألف المعصم (الرسغ) من 8 عظام رسغية تتوضع في صفين اثنين (القريب، البعيد) ومتمفصلة مع بعضها البعض، وهي من الوحشي إلى الإنسي:

القريب	القاربي Scaphoid	الهلالي Lunate	المثلثي Triquetrum	الحمصي Pisiform
البعيد	المربعي Trapezium	شبه المنحرف Trapezoid	الكبير Capitate	الكلابي Hamate

- تُعتبر المفاصل بين عظام الرسغ كمفصل واحد وهو المعصم.

أما مفاصل الأصابع فهي:

- المفاصل السنعية السلامية Metacarpophalangeal (MCP).
- المفاصل بين السلامية القريبة Proximal Interphalangeal (PIP).
- المفاصل بين السلامية البعيدة Distal Interphalangeal (DIP).

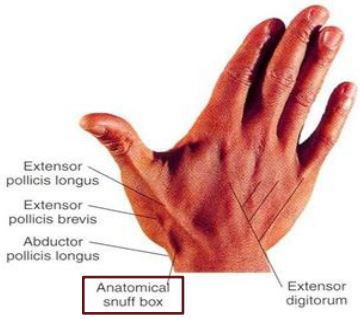


مفاصل اليد والمعصم

لتسهيل حفظ عظام الرسغ
قرب الهلال مثلث مع حمصة والربع منحرف بكبر كلابي

منشقة المشرحين Anatomical snuff box: RBO Clinical

- هي منطقة بين وتري **مبعدة الإبهام الطويلة وباسطة الإبهام القصيرة** في الوحشي و**وتر باسطة الإبهام الطويلة** في الإنسي.
- يمكن تحديد **التهاب الأوتار** ضمن هذه المنطقة، كما يحدث ألم فيها عند **كسر العظم الزورقي (القاربي Scaphoid)**.



صورة تُوضح موقع منشقة المشرحين

التظاهرات المفصلية للأمراض الجهازية

- الأمراض **المفصلية** يمكن أن تدلنا على أمراض **جهازية غير مفصلية**، فمثلاً من تأمل اليدين يمكننا ملاحظة:
  - **تبقرط الأصابع** والذي يدلنا على **نقص الأكسجة** وبالتالي **مشكلة قلبية أو رئوية** (كتليف الرئة مثلاً).
  - **تنخُّرات أو اسوداد برؤوس الأصابع** فقد نتوجه للشك بـ **نقص التروية** (إصابة قلبية).
  - **الحمامى الراحية (احمرار شديد في راحة اليد)** فتوجه تفكيرنا لوجود مشكلة في **الكبد** (تشمُّع الكبد).
  - **احمرار اليدين** يدل على وجود **تورم**.
  - **ازرقاق برؤوس الأصابع** قد يدل على **ظاهرة رينو**.
- كل ما سبق هي أمراض عامة تظهر علاماتها على **المفاصل** ولكن علاجها يكون بمعالجة **الداء الأساسي**.

ملاحظات:

- في الداء التنكسي البدئي تحدث ضخامة عظمية في المفاصل بين السلامية **القريبة** وهنا تأتي أهمية **القصة السريرية** فالسؤال عن السوابق العائلية (هل سبق وأُصيب أحد أفراد أسرتك بمثل هذه الضخامة؟) يوجهنا للداء التنكسي البدئي والذي **لا علاج له** (لأنه وراثي) لذا نقوم بإعطاء المسكنات.
- التهاب زليل تحت سريري: لا يظهر الألم إلا بعد الضغط على المفصل، ولا يكون المريض على علم به (حيث أن الالتهاب تحت السريري يعني أنه يوجد التهاب لكنه غير ظاهر سريرياً، أي أعراضه غير ظاهرة).

فحص اليدين

يتضمن:

1. فحص المفاصل:

- التورم، التشوهات، ...

2. فحص الأظافر:

- حيث يمكن أن تعطي علامات على: الصداف، التهاب الأوعية (قد يكون في سياق الداء الرثياني)، التوسعات الشعرية، التهاب شغاف القلب، فقر الدم.

3. فحص الراحتين:

- نلاحظ التهاب أوعية، التهاب أغماد الأوتار، ضمور عضلي في عضلات اليد بسبب عدم الاستعمال أو بسبب الانضغاط العصبي، حمامى راحية[1] Palmar erythema (يد حمراء).

4. فحص قوة اليد:

- يتم هذا الفحص من خلال تحديد القوة العضلية بمقياس من 6 درجات، كما نعلم العضلة وظيفتها التقلص وبالتالي عند:

عدم وجود تقلص مطلقاً	يوجد تقلص لكن دون حركة	تقلص مع حركة
درجة القوة (0)	درجة القوة (1)	درجة القوة (2)
تقلص يؤدي لحركة ضد الجاذبية	تقلص يؤدي لحركة ضد الجاذبية وضد مقاومة الفاحص	إذا غلب المريض الفاحص بالحركة
درجة القوة (3)	درجة القوة (4)	درجة القوة (5)

5. فحص وجود ندبات عمل جراحي سابق:

- إصلاح أو نقل أوتار.
- التهاب الأوعية في الجلد:

☜ فرفريات Purpura، أما التهاب الوُريدات خاصةً فيُدعى بالتزرُّف الشبكي Livedo reticularis.

[1] ستجد صورة لها في الصفحة 6.

6. اسوداد الأنامل:

يحدث بسبب **التهاب الأوعية** وانقطاع التروية مثل التهاب النسيج ما حول الشرايين أو **التهاب الشرايين العقدي**، حيث يؤدي التهاب الأوعية الجلدية إلى تضيق لمعة الوعاء وبالتالي ينجم عن ذلك نقص في تروية النسيج الذي يرويه هذا الوعاء، وفي حالات **الالتهاب الشديدة قد ينسد الوعاء ويقود للتنخُّر**[2] **والتموُّت**.

إنّ التنخرات في رؤوس الأصابع عبارة عن تنخرات ناتجة عن نقص التروية في سياق التهاب الأوعية الذي يعد من أهم الأمراض التي تسبب تنخرات رؤوس الأصابع.

نقص التروية في الشُّرينات يسبب تنخرات

نقص التروية في الوُريدات يسبب تزرق شبكي



أحد أشكال التهاب الأوعية

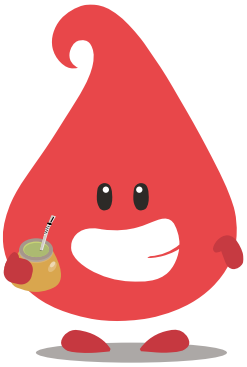


التزرق الشبكي

خطوات الفحص:

تتم من خلال:

التأمل ← الجس ← فحص الحركة



EXTRA

[2] التنخُّر الّذي يحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى الخلايا يسبب ما يسمى بالغرغرينا Gangrene وهي تسبب اسوداد الأصابع أيضاً.

1. التأمل Inspection:

IMP

الجلد	التورم المفصلي	التشوهات	الضمور العضلي
• نلاحظ الاحمرار كحالة الحمامى الراحية، الطفح (الشرى)، ضمور العضلات، الندبات، تغير اللون (ظاهرة رينو).	• نحدد توزعه: أي نتحرى عدد المفاصل المصابة وتناظر الإصابة.	• كما في الداء الرثياني، الصداف، الداء التنكسي.	• ضمور عضلات اليد الداخلية، وضمور العضلات بين عظام الأسناع الملاحظ في ظهر اليد.

الضمور العضلي:

RBO Clinical

- يجب التفريق بين ضمور العضلات بين الأسناع الذي يظهر أحياناً لدى المسنين بسبب الشيخوخة والي **لا يترافق** بضعف عضلي، وبين الضمور بسبب الداء الرثياني والذي **يترافق** بضعف عضلي.



الحمامى الراحية (اليد الحمراء)



الضمور العضلي لعضلات اليد

2. الجسّ Palpation:

♠ يكون فحص المفاصل من الوجه **الظهري** لليد:

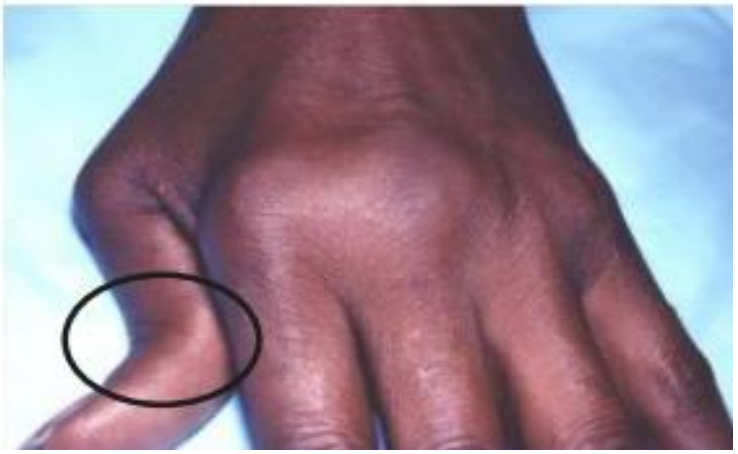
العضو المفحوص	الفحص
المعصمان	▪ استشعار الحرارة الموضعية، البحث عن التهاب الغشاء الزليل، الانصباب، مدى الحركة، الفرقعة، إيلام **الناتئ الإبري الزندي والإبري الكعبري** (اللذان قد يكونان **أولى** تظاهرات الداء الرثياني). ▪ يفحصهما الطبيب باستخدام كلتا يديه.

العضو المفحوص	الفحص
المفاصل السنعية السلامية (MCP)	▪ نقوم بالجس للكشف عما يلي: ✓ التهاب الغشاء الزليل والانصباب، مدى الحركة، الفرقعة، تحت الخلع. ▪ يفحصه الطبيب باستخدام **إصبعين فقط**.
المفاصل بين السلامية الدانية (PIP) والقاصية (DIP)	▪ نجس المفاصل بين السلامية الدانية والقاصية للبحث عن: ✓ الإيلام والتورم، المناقير والضخامة العظمية. ▪ يفحصهما الطبيب باستخدام **أربع أصابع**، إصبعين من الجانبين وإصبع من الأعلى والأخير من الأسفل.
الفرقعة في أوتار راحة اليد	▪ تدل على **التهاب غمد الوتر**. ▪ حالة إصبع الزناد "انعقال الإصبع". (سنشرحه لاحقاً)

تحت الخلوع: EXT

RB Clinical

▪ مصطلح يشير إلى حالات معينة تتعلق بضعف أو فقدان الثبات في المفاصل، تشمل هذه الحالات الخلع الجزئي حيث يخرج جزء من المفصل من موضعه الطبيعي دون أن ينفصل بالكامل وقد يسبب تورم وألم، وتشمل أيضاً التهاب المفاصل (الرثياني مثلاً) والذي يؤدي إلى ضعف في الأنسجة المحيطة بالمفصل مما يزيد من احتمالية حدوث خلع، وهنالك أيضاً خلع الولادة والتشوهات الخلقية والإجهاد المتكرر وغيرها.



تحت الخلع يُمكن أن يُشاهد إما بالداء التنكسي أو الداء الرثياني



طريقة جس المفاصل بين السلامية

فحص أغماد أوتار راحة اليد

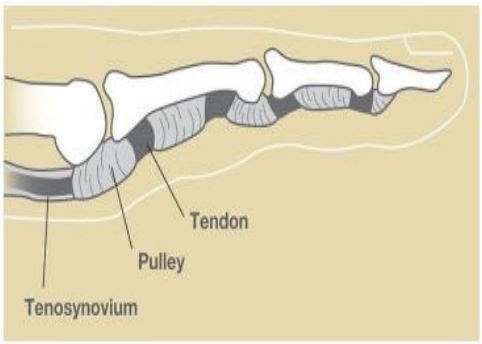
- نقوم بفحص الحركات **العاطفة** (في راحتي اليدين) **والباسطة** (في الوجه الظهري لليدين) بإجراء حركات عطف وبسط، ونتحرى عن:
  - تسمك غمد الوتر، الفرقعة أو الصرير، جس عقيدة التهابية.
- التهاب أغماد الأوتار قد يكون:

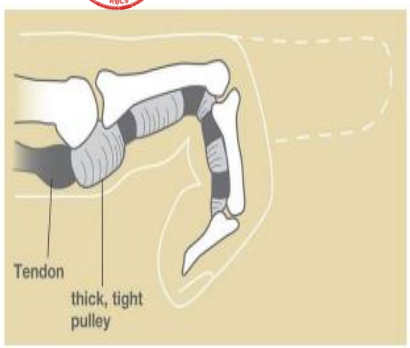
مجهول السبب نتيجة جهود الحياة اليومية	بسبب داء السكري إذا كان المريض كبيراً في العمر	في سياق الداء الرثياني

التهاب أغماد الأوتار **متوسط عتبة الألم** فتختلف درجة ألمه بين الأشخاص.

إصبع الزناد (انعقال الإصبع) Trigger Finger[3]

- هو حالة التهاب وتر وتشكل عقيدات التهابية، تسمح هذه العقيدات للمريض بإجراء حركة عطف لإصبعه المصاب بشكل طبيعي، لكنه **لا يستطيع أن يبسطها** إلا بعد حركة قفز للإصبع (نحو الأعلى) وتسمى هذه الحالة **الإصبع القافز** الناتج عن التهاب الأوتار.
- تكون على الوجه **الراحي** لليد، حيث نلاحق سير الأوتار فالكثير من المرضى يشكون من **انعقال الاصبع**.
- هذه الحالة يتم فيها عطف الإصبع بشكل طبيعي ولكن **لا** يستطيع المريض بعدها بسط إصبعه، لذا يضطر إلى استخدام **يده الأخرى** من أجل ذلك.
- المشكلة لا تقتصر على ذلك فقط بل يحدث لدى المريض **طقطقة مؤلمة جداً** وهذا ما يحدث في سياق التهاب الأوتار.
- إذا لم يعالج الوتر المصاب يؤدي ذلك بعد فترة إلى **عقلة** (تليف في الوتر) ومن ثم **عدم قدرة المريض على البسط لهذه الاصبع**.
- هذه الحالة تصيب الإصبع الأولى بشكل شائع (بدون سبب).

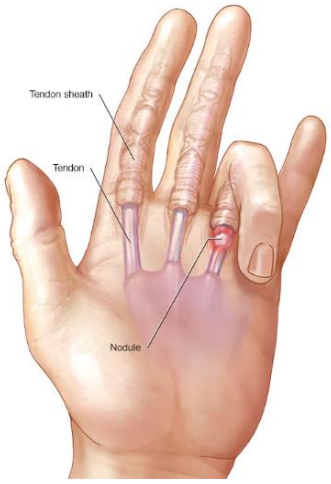




لاحظ العقيدة الالتهابية في الصورة اليسرى وانزلاقها ضمن غمد الوتر مما يؤدي إلى بقاء الإصبع في حالة عطف في الصورة اليمنى

[3] انعقال الإصبع ليس حالة سريرية بحد ذاتها وإنما نتيجة لأمراض التهاب الأوتار. EXTRA

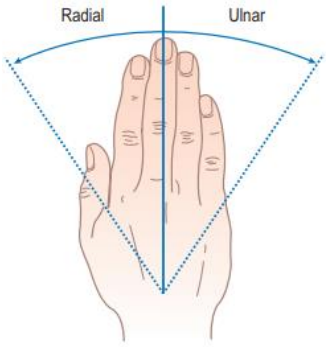
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

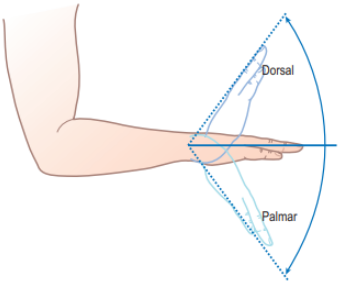


انظر للإصبع الزناد في الصورة المجاورة

3. الحركة Movement:

7. حركات المعصم:





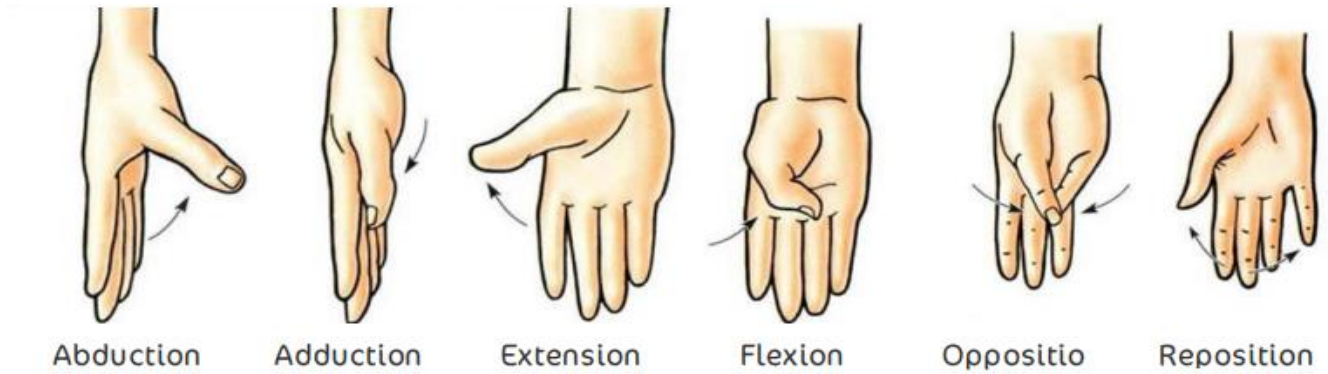
- المعصم مفصل زليلي يتحرك على **محورين**، وله **4 حركات**:
  - حركة البسط (العطف الظهري).
  - حركة العطف (العطف الراحي).
  - انحراف لجهة الكعبرة (تبعيد).
  - انحراف لجهة الزند (تقريب).

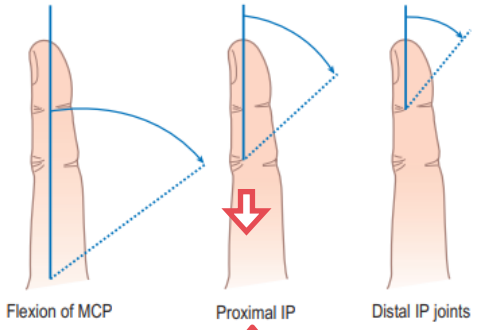
8. حركات الإبهام والأصابع:

حركات الأصابع: التبعيد والتقريب، العطف والبسط

حركات الإبهام: التقريب والتبعيد، العطف والبسط، والمقابلة

- نطلب من المريض تحريك جميع أصابعه ومقابلتها مع الإبهام، فعند عدم وجود إصابة لا يكون هناك تحدد بالحركات.



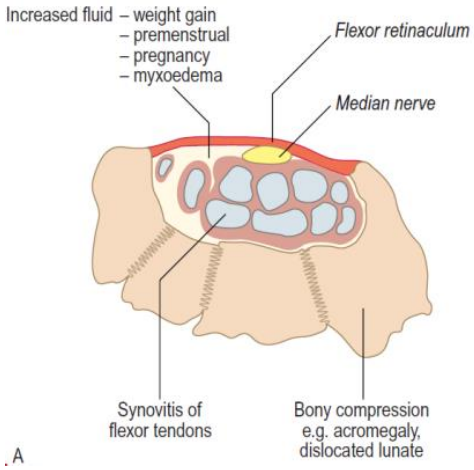


لاحظ بعض حركات الأصابع والابهام

فيديو ممتع مترجم من Macleod عن الفحص السريري لليدين مدته 6 دقائق

متلازمات الانضغاط العصبي

متلازمة نفق الرسغ (انضغاط العصب الناصف)[4] Carpal tunnel syndrome:

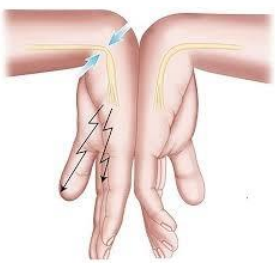


- تنجم عن انضغاط **العصب الناصف** -وهو عصب حسي حركي- نتيجة لتجمع السوائل في مفصل الرسغ بسبب أمراض عديدة (مثل قصور الغدة الدرقية[5]، الداء النشواني[6]، الداء الرثياني، ....)، ويسبب انضغاطه مجموعة من الأعراض حسب الأماكن التي يعصبها، وهو **أكثر عصب معرض للانضغاط**.
- يعصب العصب الناصف الجزء **الوحشي الأمامي من راحة اليد**[7]، ويحدث عند المريض **ألم حارق** (خاصة في الليل) في هذه الأصابع عند انضغاطه.
- الشكاية الرئيسية التي يأتي بها مريض متلازمة نفق الرسغ هي **ألم وخدر** في الأصابع المُعصَّبة بهذا العصب.

نفحصه بعلامتين مهمتين هما:

1. علامة فالن Phalen's sign:





- عطف مديد للمعصمين معاً لمدة **30 ثانية إلى دقيقة**.
- يتم العطف بزاوية **90 درجة**.
- وهكذا نكون قد **زدنا** الضغط على العصب حتى نلاحظ العلامات بوضوح أكثر.
- إذا **تحرش** الخدر والنمل مكان توزع العصب الناصف تكون **إيجابية**.

[4] ذكرنا متلازمة نفق الرسغ لنؤكد أنه ليس كل متلازمة نفق رسغ حلها جراحي.

[5] ذكر الدكتور أيضا فرط نشاط الدرق...

[6] مرض ينتج عن تجمع البروتين النشواني (الأميلويد) في أعضاء وأنسجة الجسم. EXTRA

[7] يعصب هذا العصب أول 3.5 أصابع من الوحشي، أي الإبهام والسبابة والوسطى والنصف الوحشي للبنصر.

2. علامة تينيل Tinel's sign:



✪ نطرق بالمطرقة على قيد القابضات **فوق غمد العصب الناصف** (أي عند مخرج العصب)، إذا **تحرض** الخدر والنمل مكان توزع العصب تكون **إيجابية**.

من الأمور المساعدة في التشخيص هو **تخطيط الأعصاب**.

- يجب الأخذ بالعلم أن **إيجابية** الاختبارات (فالن وتينيل) **لا تعني حتماً وجود إصابة** وكذلك **سلبية** هذه الاختبارات - في حال وجود شكاية- **لا تحتم عدم وجود إصابة**، وفي كلتا الحالتين يجب فحص العصب (أي أن الإيجابية **توجه** والسلبية **لا تنفي** وجود الإصابة).
- من الحالات التي قد يحدث فيها انضغاط عصب ناصف هي **الحمل** بسبب **الوذمات** وبعد انتهاء الحمل والنفاس تذهب أعراض انضغاط هذا العصب (لا حاجة للجراحة هُنا).
- **قصور الدرق** يؤدي أيضاً إلى انضغاط العصب الناصف بسبب **تجمع المادة المخاطية في النسج الخلالية حوله**، والعلاج هنا أيضاً ليس علاج جراحي وإنما علاج للغدة الدرقية.

↙ يتم علاج متلازمة نفق الرسغ بأربع طرق وهي بالترتيب:

الطريقة الأولى	تتم بمعالجة السبب المستبطن (مثلاً معالجة التهاب المفاصل الرثياني، الداء النشواني، قصور الدرق، السكري، البدانة)
الطريقة الثانية	بالعلاج الدوائي، كما في حالة إعطاء المدرات للمرأة الحامل بعد ولادتها، أو إعطاء مضادات التهاب غير الستيروئيدية لمرضى الداء الرثياني
الطريقة الثالثة	تتم بحقن الكورتيزون (حقن موضعي) وهو إجراء **سهل وغير مؤذي ومكلف**
الطريقة الرابعة	بالعلاج الجراحي (تحرير قيد القابضات)، حيث يتم ذلك **بعد التأكد** من المرض عبر تخطيط الأعصاب ونفي وجود الأمراض المسببة

ملاحظة

في الحالات السابقة إذا لم يثبت أن المشكلة خارج قيد القابضات ولم يتحسن المريض على مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (فمويًا أو حقن موضعي إذا لم يستجب) هذا يعني أنه يوجد **تسمُّك** بقيد القابضات وحل هذه المشكلة **جراحي**.

ملاحظات:

- العصب الناصف له ألياف حركية وألياف حسية وليس بالضرورة أن تكون الإصابة حركية وحسية معاً، فمن الممكن أن تكون حسية أو حركية أو كلاهما معاً.
- عند إصابة العصب الناصف يعاني المريض من الخدر والنمل مكان توزعه ولكن ممكن أن يعاني أيضاً من الألم.

حالة سريريّة: RBO Clinical

- سيدة بدينة أو لديها قصور درق أو داء رثياني أو داء نشواني أو حامل (كل ما سبق من **أسباب** متلازمة نفق الرسغ)، تشتكي أنها تستيقظ ليلاً ويداها مخدرتين ومنملتين ولا يخف الألم حتى تنفض يداها (كل ما سبق **أعراض** وصفية لمتلازمة نفق الرسغ).
- فنجري لها الاختبارين (فالن، تينيل).

✓ إذا كانا **سلبيان**: فهذا لا يعني أنها لا تعاني من متلازمة نفق الرسغ بل يجب تأكيد الإصابة بإجراء **تخطيط للعصب الناصف**.

✓ إذا كانا **إيجابيان**: فهذا يوجهنا بشدة للتشخيص ولكن التشخيص الأكيد هو **بتخطيط العصب الناصف**.

التشوّهات

عندما نستخدم تعبير تخرّب مفصلي أو تآكلات (العظم حوافه مُشرشرة ومتآكلة) فهذا يعني **ظهور التآكل على الصورة الشعاعيّة** وحكماً وجود **تشوّه مرئي** للعيان ولكن **العكس غير صحيح**.

➤ أي يمكن أن يكون الشخص يده مشوّهة ولكن لا يوجد تخريب مفصلي ولا يظهر التشوّه على الصورة الشعاعيّة كما في **الذئبة الحمامية**، **متلازمة جاكو** (حيث تحدث ضخامة وترية بسبب التشوه).

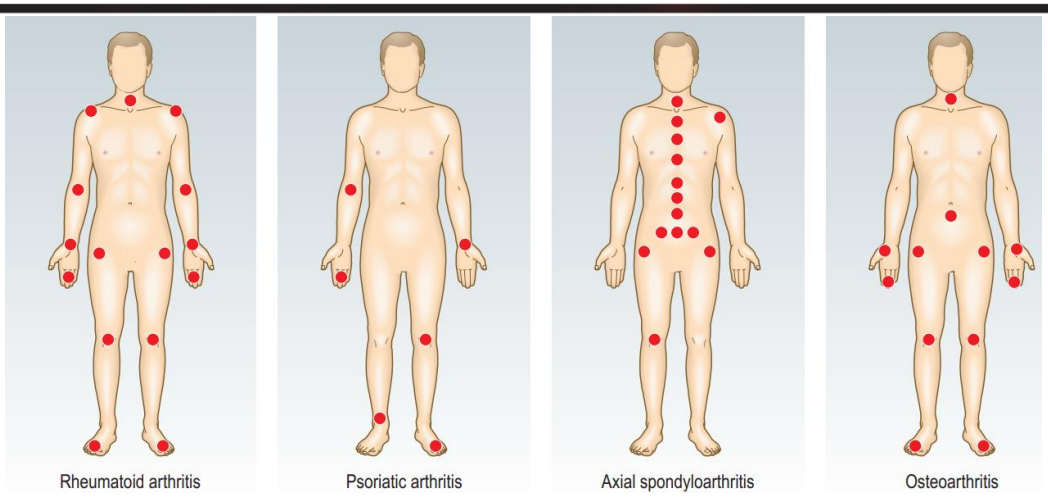
↙ بالمختصر؛ كيف نفرق بين التهاب المفاصل الرثياني والذئبة الحمامية؟

☜ نقوم بإجراء صورة شعاعية لليدين، ونلاحظ الاتي:

في التهاب المفاصل الرثياني	في مرض الذئبة الحمامية الجهازية
تكون العظام **متخرية** ومشوهة لمظهر العظم (لأن الداء الرثياني مخرِّب ومشوِّه[8])	تكون العظام سليمة **غير متخرية** لكنها مشوّهة للمظهر فقط

[8] ربما في بداية المرض لن نستطيع ملاحظتها. EXTRA

لاحظ الفرق بين تناظر وأماكن إصابة المفاصل في الداء الرثياني مقارنة بباقي نماذج الأمراض الرثوية



التشوّهات في سياق الداء الرثياني Rheumatoid arthritis:

IMP

- **الداء الرثياني**: هو التهاب مفاصل **متناظر**، يصيب المفاصل **كافة** وبشكل خاص المفاصل **الصغيرة**، وهو من **أشد** الأمراض المفصلية **تشويهاً وتخريباً**، يصيب **الغشاء الزليلي**.
- يلتهب فيه (المفصل، أغماد الأوتار، قد تحدث فيه خلوع التهابيّة وتحت خلوع، تمزُّقات وتريّة، وتخرّب مفصلي).
- وهو يصيب **اليدين والمعصمين** في 90% من الحالات، من تشوّهاته:

التشوه	سببه
الانحراف الزندي للأصابع	• نتيجة تحت الخلوع في المعصم وتحت الخلوع في المفاصل السّنعية السّلامية (MCP).
تحت الخلع الراحي للأصابع	-
عنق الإوزة Swan Neck	• فرط بسط في المفصل بين السّلامي الدّاني (PIP). • فرط عطف في المفصل بين السّلامي القاصي (DIP).
عروة الزر Boutonniere	• فرط عطف في المفصل بين السّلامي الدّاني (PIP). • فرط بسط في المفصل بين السّلامي القاصي (DIP).
مطرقة الأصابع Mallet	• يكون شكل الإصبع يشبه المطرقة. • المفصل بين السّلامي الدّاني (PIP) طبيعي والمفصل بين السّلامي القاصي (DIP) في حالة عطف.
الإبهام بشكل Z	• فرط بسط بالمفصل بين السّلامي مع تشوه ثابت بالانعطاف وتحت خلع في المفصل السّنعي السّلامي (MCP).
منظار الأوبرا	• قصر الأصابع والتشوه بشكل منظار الأوبرا في المفاصل بين السّلامية البعيدة (DIP).

الانحراف الزندي من تشوهات الداء الرثياني ولكن عند وجوده لدى أنثى شابة فقد تكون مصابة بالذئبة الحمامية.



تشوه منظار الأوبرا



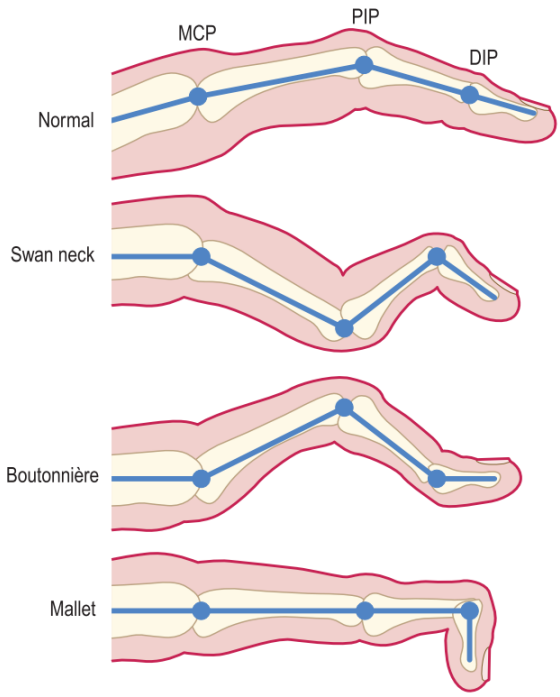
تشوه الإبهام بشكل Z



عنق الإوزة



عروة الزر



لاحظ في الصورة المجاورة كيفية حدوث كل من عنق الإوزة Swan neck، عروة الزر Boutonniere، ومطرقة الأصابع Mallet بالمقارنة مع الطبيعي

لماذا سمّي تشوّه عروة الزر (Boutonniere) بهذا الاسم؟

- بالتخريب يصاب غمد الوتر الباسط فيتمزق وذلك يشبه تمزق فتحة الزر، والمفصل المتخرب بالأصل شكله هضبي، فيخرج المفصل من داخل الوتر المتمزق، ويصبح بذلك يشبه الزر الخارج من العروة.
- قد تحدث حالة عروة الزر بإصبع وعنق الإوزة بالإصبع المجاورة له.

التشوهات في سياق الداء التنكُّسي Osteoarthritis:

- من التهابات **الفقار سلبي المصل**.
- نحن نعلم أنّه في الداء التنكّسي يتشكّل ما يسمّى بِـ "المناقير العظميّة" التي تسمّى حسب مكان ظهورها:

عقد بوشارد Bouchard's nodes	عقد هيبردن Heberden's nodes
عندما تظهر على جانبي المفاصل بين السّلاميّة **الدانية (PIP)**	عندما تظهر على شكل عقيدات على جانب السلاميّات **القاصية (DIP)**

- عقد بوشارد على الPIP قد تشير إلى الذئبة الحمامية أو الداء الرثياني.
- عقد هيبردن على الDIP قد تشير إلى النقرس أو التهاب المفاصل الصدافي.



لاحظ عقد بوشارد وهيبردن على جانبي المفاصل بين السلامية الدانية والقاصية





تذكر الصورة اليمنى من المحاضرة الماضية، إذ كانت تمثل يد مريض المناقير حيث:
يشير السهم الوحيد إلى عقد هيبردن.
يشير السهمين إلى عقد بوشارد.

انظر الصورة اليسرى التي تمثل الإصبع النقانقية



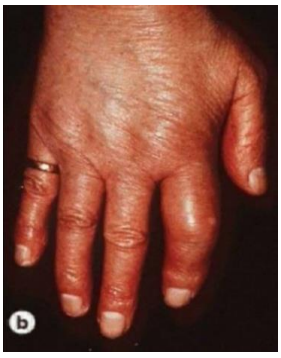
- المظهر العياني؛ تميزه **الإصبع النقانقية** التي تكون متورمة بِعَرْض واحد بسبب التهاب **الأوتار المحيطية**.
- **الإبهام** له ميزة حيث لا يوجد فيه سوى **سلاميتين**، ولذلك يتميز المفصل الرسغي السنعي الأول (نسميه أيضا قاعدة الإبهام) بأنه يصاب كثيراً، خصوصاً في **الداء التنكسي**.

- في الداء الرثياني **تصاب** المفاصل السنعية السلامية MCP والمفاصل بين السلامية القريبة PIP فقط و**لا تصاب** المفاصل بين السلامية البعيدة DIP إلا في حالات نادرة جداً (تشكل 1% من الحالات تقريباً).
- تصاب المفاصل بين السلامية البعيدة والقريبة في **الداء التنكسي البدئي والذئبة الحمامية** على حدٍ سواء.
- عند إصابة المفاصل بين السلامية البعيدة لا نقول إنه داء رثياني **حتى ننفي كل الأمراض الأخرى**.

RBO Clinical
حالة سريريّة:

- سيدة لديها إصابة بالمفاصل بين السلامية القريبة والبعيدة وعند الفحص وجد أن لديها ضخامة عظمية أكثر من كونها التهاب فماذا نفعل؟
- نسألها عن القصة العائلية ففي حال تبين وجود أحد أفراد العائلة مصاب بالداء **التنكسي البدئي** فهنا لا علاج لها (لا جراحي ولا غيرو) نعطيها مسكنات ونطلب منها أن تريح نفسها لأن هذا الداء ليس **روماتيزمي (رثياني)**.

التشوهات في سياق التهاب المفاصل الصدافي Psoriatic arthritis:



♠ **الصداف:**

- مرض **جلدي** يصيب حالات قليلة (فقط 5 - 7 ٪ من الأشخاص يحدث لديهم التهاب مفاصل صدافي) يترافق بإصابات **مفصلية** مخربة بشدة.
- له عدّة أشكال (محيطيّة مخرّبة بشدّة - محوريّة مثل التهاب الفقار الصدفي).
- وهنا نتحدّث عن **الشكل المخرّب بشدّة** الذي يصيب اليدين مع وجود قشور بيضاء.
- من التشوّهات:

التهاب المفاصل الباتر	التهاب الأصابع (الأصابع النقانقيّة)	التبدّلات الظفريّة
تشوّه بشكل المنظار بسبب التخريب الشديد في السلاميّات والأسناع (تنحل) يُرى بالأشعّة	التي سببها التهاب المفاصل السنعيّة السلاميّة وبين السلاميّة القاصية والدانية والتهاب أغماد الأوتار (يعني كل الأصبع)	توهد - انفكاك الظّفر - فرط تقرّن



انظر إلى فرط تقرّن الظفر الملاحظ في التهاب المفاصل الصدافي



دقّق في انفكاك الظفر Onycholysis الظاهر في الصورة أعلاه



أما هنا فلاحظ توهد الأظافر Koilonychia

تورم المفصل	+	المعالم غائبة	= مشكلة مفصلية
ألم مرفق	+	عند التحريك لا ألم	= مشكلة غير مفصلية
ألم مرفق	+	يتحرض فقط بالمناورات	= مشكلة بأربطة المفصل

ملاحظات:

- بعض الآفات المعويّة اللاتهابية (**داء كرون** و**التهاب القولون القرحي**) واعتلالات المفاصل الفقارية Spondyloarthritis التي تشمل (**داء الفقار المقسط**، **داء رايتر**، والتهاب المفاصل الصدافي كما ذكرنا، وغيرها) يسبّبان اعتلال المفاصل ويؤدّيان إلى **الأصابع النقانقيّة**.
- مفهوم العامل الرثياني[9] هو الأجسام المضادة (IgM أو IgG أو IgA) ضد القطعة FC من الـ IgG وهو **نوعي** للداء الرثياني ولكن يوجد في 70% من الأشخاص المصابين.

المرفقان

✓ يتألف مفصل المرفق (وهو مفصل من النمط البكري Hinge Joint) من جوفين مفصليين:

- الجوف بين العضد من جهة والزند والكعبرة من جهة أخرى (مسؤول عن البسط والعطف).
- الجوف بين الزند والكعبرة -المفصل الزندي الكعبري العلوي- (مسؤول عن الكب والاستلقاء).

✓ حركات المرفق: عطف وبسط **فقط**.



[9] كما ذكرها الدكتور.

خطوات فحص المرفقين

تتم من خلال:

التأمل ← الجس ← فحص الحركة

التأمل Inspection:

- نلاحظ الآتي:

التورم المفصلي: هو تورّم شامل للمفصل يؤدّي لغياب تضاريسه ويترافق مع ألم وتحدّد في الحركة، هنا تكون الإصابة في الجوف المفصلي (التهاب الغشاء الزليلي والانصباب).

تورّمات خفيفة على السطح الباسط للمفصل: إمّا فوق النتوء المرفقي أو تحت جلد حافّة عظم الزند في قسمها العلوي، منها العقيدات الرثيانيّة، كما نشاهد عقيدات أخرى في العديد من الأمراض مثل الذئبة الحمامية، التهاب الجلد والعضلات.

توفِيّات (حصيات Tophi) النقرس: وهي تورّمات (ترسبات) محتواها حمض البول ونراها في النقرس المزمن[10].

بعض الأورام الصفراء: عند الأشخاص الذين لديهم فرط كوليسترول.

تورّم واضح الحدود لايشمل كل سطوح المفصل: سببها التهاب الجراب (شاهد الصورة) أمام النتوء المرفقي.



العقيدات الرثيانيّة عند نتوء المرفق تحت جلد حافة الزند العلوية



شاهد التهاب الجراب أمام النتوء المرفقي

[10] قد تظهر على المفاصل بين السلامية القاصية (DIP)، ويمكن تميزها عن عقد هيبردن الخاصة بالداء التنكسي، هناك صورة لها في المحاضرة السابقة في الصفحة 15.

الجس Palpation:

- جس الحرارة الموضعية لتحري الانصباب والتهاب الغشاء الزليلي.
- جس النتوء المرفقي (الزجّ Olecranon).
- نتحرّى الإيلام في مكان ارتكاز أوتار العضلات على اللقيمات حيث:

التهاب أوتار اللقيمة الوحشية	التهاب أوتار اللقيمة الإنسية
يؤدي جس منشأ العضلات **الباسطة** للمعصم على **اللقيمة الوحشية** إلى إثارة الألم (مرفق التنس)	يؤدي جس منشأ العضلات **العاطفة** للمعصم على **اللقيمة الانسية** إلى إثارة الألم (مرفق الغولف)



جس اللقيمة الوحشية



جس اللقيمة

ملاحظات:

- عندما يكون الجوف المفصلي هو المؤلم والملتهب أي يوجد انصباب أو التهاب غشاء زليل أو إصابة عظميّة (مثل نخر أو غيره) فإن حركات المفصل كلها تكون **مؤلمة**.
- بينما إذا كانت الإصابة وتريّة **فقط**، فتتأذى الحركة المسؤول عنها الوتر المصاب وتصبح مؤلمة، لذلك يجب أن نعرف ماذا يحرّك كل وتر حتّى نعرف كيف نفحصه.
- يكون فحص الأوتار بإجراء حركة بوجود مقاومة فإذا تألّم المريض نعلم أنّ **الوتر مصاب**.
- مثلاً: العضلة ذات الرأسين مسؤولة عن حركة العطف فإذا التهب وتر ذات الرأسين يتألّم المريض في حركة العطف فقط، ويكون الفحص بأن أطلب من المريض أن يعطف يده وأنا أقوم بمقاومة العطف، حيث أنّ الشخص السوي لا يتألّم عند مقاومة أي حركة يقوم بها، ولكن إذا كان الوتر ملتهباً إجراء الحركة المسؤول عنها الوتر تجاه مقاومة تكون مؤلمة.
- أثناء الفحص يكن المرفق معطوف بزاوية 90° لأن معالمه تكون واضحة.



	مرفق الغولف	مرفق التنس
كيفية تحري إصابتها	إجهاد العضلات العاطفة للمعصم، وذلك بمقاومة الفاحص لحركة عطف المعصم مما يثير الألم 	إجهاد العضلات الباسطة للمعصم، وذلك بمقاومة الفاحص لحركة بسط المعصم مما يثير الألم 

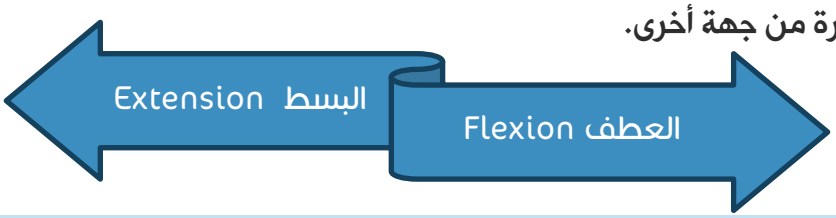
يكون علاج مرفق الغولف ومرفق التنس **دوائياً**، وإذا لم تتحسن الحالة يكون العلاج بحقن الستيروئيدات تحت الجلد مباشرةً فوق الوتر.

الحركة Movement

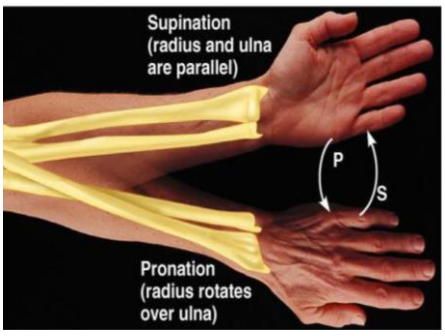
- يتم فيها تحري:

1. حركات المرفق:

- للمرفق حركة واحدة (أي أنه يتحرك على محور واحد مثل الباب) ألا وهي: العطف والبسط وذلك بين العضد من جهة والزند والكعبرة من جهة أخرى.

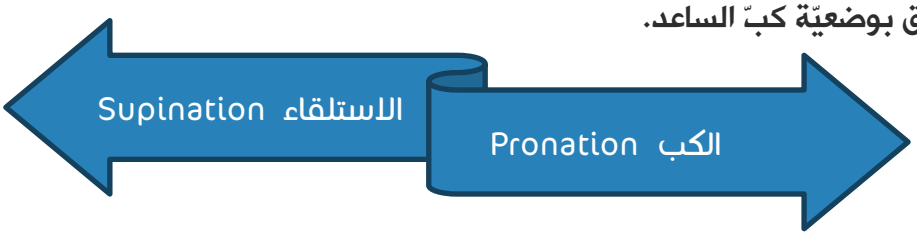


2. حركات الساعد:



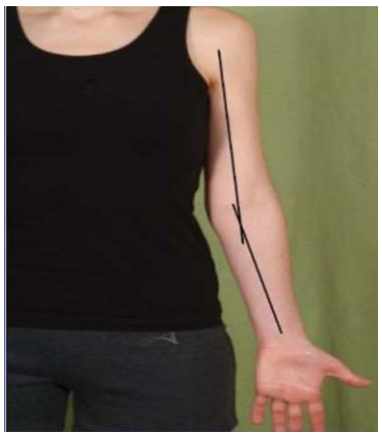
- وهي حركات بين (الزند) و (الكعبرة).
- نلاحظ أنّه خلال حركة **الاستلقاء** للساعد، عظما الزند والكعبرة يتوازيان بينما في **الكبّ** يتصالبان.
- عند حدوث كسر لإحدى هاتين العظمتين فتصبح حركات الكبّ والاستلقاء **غير ممكنة** خاصّةً في حال حدوث اندمال معيب للكسر (التحام بتوضّع **غير** تشريحي أي بصورة خاطئة).

- للتأكد من سلامة المرفق يقوم المريض بالحركات التالية:
  - بسط المرفق بوضعيّة استلقاء الساعد.
  - عطف المرفق بوضعيّة كبّ الساعد.



في أغلب الحالات أول عَرَض لمرض التهاب المفاصل الرثياني هو **تحدّد بسط المرفق**.





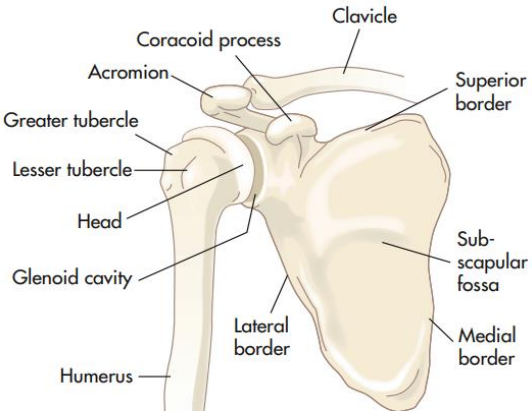
مفصل الكتف

مقدمة

➤ **تذكرة تشريحيّة**: مفصل الكتف هو اتصال رأس العضد مع الجوف الحقاني لعظم الكتف، وهو من المفاصل الزليلية (التي تتألف من محفظة زليليّة وغشاء زليلي وبعض البنى الإضافيّة مثل **الأربطة**).

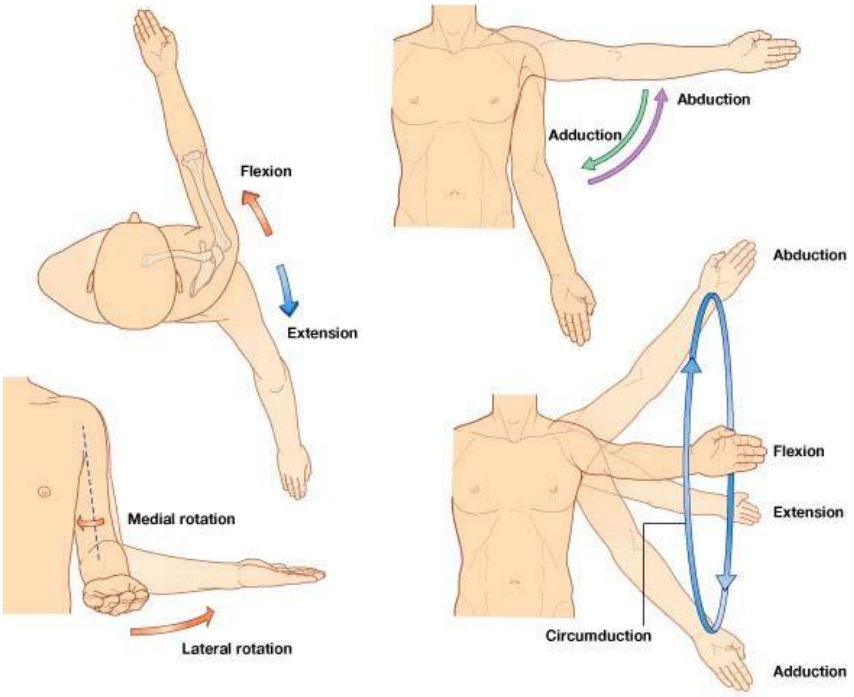
↙ يساهم في حركات الكتف:

- المفصل الكتفي العضدي وهو المفصل الرئيسي (كروي واسع الحركة جداً).
- المفصل الترقوي الأخرمي.
- المفصل القصي الترقوي.
- حركة اللوح على جدار الصدر.



➤ يُعتبر **ألم الكتف شائعاً**، ويحدث الألم في هذه المنطقة في سياق كثير من الأمراض مثل (الداء الرثياني- التهاب المفصل القيحي، ...)، ويمكن أن تؤدي الإصابات **لتيبس** في هذا المفصل، كما في التهاب محفظة الكتف (**الكتف المتجمدة**) والتي تسبب **تحدداً في حركات الكتف** ونشاهدها غالباً عند مرضى السكري والتهاب الأوتار والتهاب الأجربة.

توجد الأجربة بين أوتار العضلات والعظم من أجل تخفيف الاحتكاك ويمكن أن تتعرض للإصابة بمختلف الحدثيات المرضية.



والآن مع فيديو آخر مترجم من Macleod عن فحص الكتف مدته 5 دقائق تقريباً

فحص مفصل الكتف Physical Examination

❖ قبل أن نبدأ بفحص مفصل الكتف يجب ألا ننسى **الألم الرجيع** الذي قد ينتج من:

- **العمود الفقري**: نتيجة حدوث الآفات القرصية.
- **الرئتين**: وخصوصاً **ألم قاعدة الرئة اليمنى** (ذات الرئة القاعدية) الذي يرجع إلى الكتف الأيمن.
- **المرارة**: يرجع ألم المرارة إلى الكتف الأيمن، ويمكن للمريض ألا يشعر في مكان المرارة في المراق الأيمن إلا بألم بسيط لا يعيره أية أهمية تذكر.
- **القلب**: ألم القلب يرجع إلى الكتف الأيسر ويشكو المريض من شعور **بثقل** في الكتف والذراع الأيسر.

كيف نميز إذا كان الألم رجيعاً أم لا؟

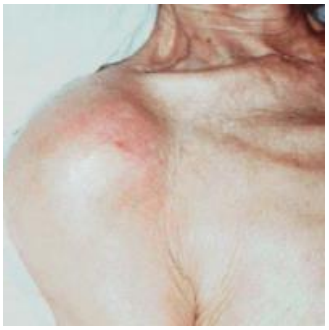
- إذا كان الألم رجيعاً: سيكون فحص الكتف **طبيعياً** مئة في المئة أي أنّ حركات الكتف كلها ستكون سليمة.
- وجود بعض الأعراض المرافقة مثلاً: عند مريض احتشاء العضلة القلبية يوجد الألم، التعرق، الغثيان، اضطراب النبض، ...إلخ.
- كتف أيسر يدل على **احتشاء القلب**، كتف أيمن يدل على **التهاب المرارة**.
- **المناورة الفاصلة** هي تحريك الكتف فعند عدم تحريض الألم فالألم رجيع، أما إذا حدث ألم اثناء الفحص فالمشكلة بالكتف.

تسلسل فحص المفصل:

- ويكون بـ:

التأمل ← الجس ← فحص الحركة

1. التأمل Inspection:



- يكون التأمل من الأمام والخلف front and back، ويجب التأكد من:
  - الهندسة السوية للمفصل ومقدار ارتفاع الكتف وعظم الكتف.
  - **تناظر الكتفين Symmetry**: أي **عدم** وجود كتف أعلى من آخر (عدم التناظر asymmetry).
  - **عدم** وجود **ضمور في العضلات muscle atrophy**.
  - **التورم**: ويشاهد في حالات الخلع والكسور القريبة للعضد والالتهابات المفصليّة.

تورم مفصل الرسغ والأصابع يكون ظاهر عيانياً لأنها مفاصل **سطحية**، على عكس مفصل الكتف الذي لا يظهر تورمه عيانياً إلا **بالحالات الشديدة** لأنه مفصل عميق، مثل التهاب غشاء زليلي أو وجود انصباب غزير في التهاب المفاصل القيحي.

2. الجس Palpation:

- نبحث فيه عن التورم وطبيعته والايلام.
- توجد نقاط علام أساسية يجب تحديدها وجسها أثناء الفحص وهي:

المفصل الأخرمي الترقوي Acromioclavicular joint: إذ نجسّ الترقوة من الأمام وشوك الكتف من الخلف، فتكون نقطة التقائهما مكان المفصل	حديبة العضد الكبرى Greater Tubercle	الناتئ الغرابي Coracoid process

3. الحركة Movement:

✧ كما نعلم، فإن مفصل الكتف من المفاصل **الكروية** له حركات **واسعة** (دوران وحشي، دوران إنسي، تبعيد، تقريب، عطف، بسط، حركات دورانية) فنبحث عن:

تحدد الحركة ← الألم ← الفرقعة المفصلية

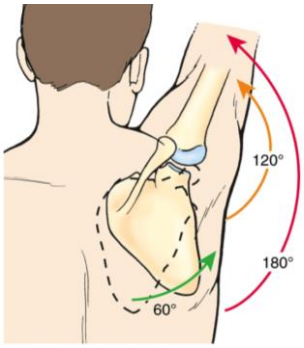
✧ نبدأ الفحص بتحريك الكتف **بدءاً من الوضعية صفر**، ونقوم **بالحركات الدورانية**، والتي نستطيع القيام بها بأكثر من طريقة، كما نستطيع **القيام بحركات مركبة** مثل (حركة العطف مع دوران إنسي- حركة تبعيد مع دوران وحشي) وهذه الحركات فحصها هام عند فحص **الآفات الوترية**.

✧ يجب أن يقف الفاحص **خلف المريض** ويمسك بذراعه بطريقة معينة بحيث تكون **أصابعه** من **الأمام** لتحس **بالترقوة** و**الابهام** من **الخلف** لتحسس حركة **لوح الكتف** على جدار الصدر، لأنّ طريقة المسك هذه تسمح بالشعور بحركة المفاصل أثناء تحريك الكتف.

يكون تأمل الكتف من **الأمام والخلف**، بينما يقف الفاحص **خلف** المريض حصراً عند فحص حركة المفصل.

ملاحظة

عندما يقوم شخص برفع ذراعه حتى 90- 120 درجة لا يتحرك لوح الكتف لأن المسؤول عن هذه الحركة هو المفصل الكتفي العضدي بالذات، لكن إذا رفع ذراعه أكثر من ذلك نلاحظ تحرك لوح الكتف على جدار الصدر.



حركات مفصل الكتف

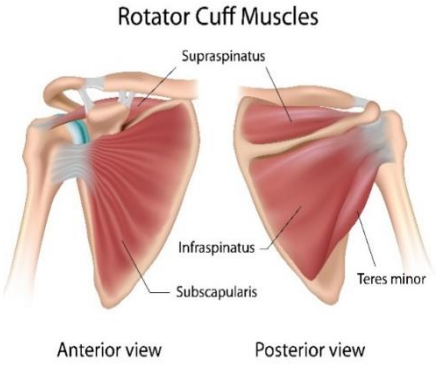
1. العطف والبسط:

✓ مدى حركة العطف **180 درجة** والبسط حوالي **60 درجة**.

2. التقريب مع الدوران الإنسي والتبعيد مع الدوران الوحشي:

- ✓ الدوران الوحشي يتم بواسطة **المفصل الكتفي العضدي بالذات** ولا يساهم به أي مفصل آخر.
- ✓ وجود الجذع يعيق الدوران الإنسي لذلك غالباً نفحصه بإجراء دوران إنسي مع تقريب.

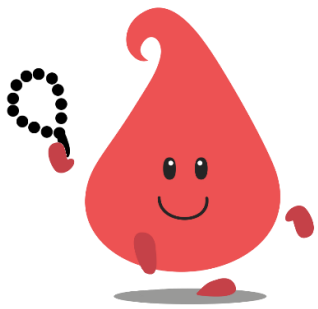
IMP عضلات الكم المدوِّر Muscles Of The Rotator Cuff:



1. **فوق الشوكية Supraspinatus**: وهي الأهم، وتقوم **بالتبعيد**.
2. **تحت الشوكية Infraspinatus**: وتقوم **بالدوران الوحشي**.
3. **تحت الكتفية Subscapularis**: وتقوم **بالدوران الإنسي**.
4. **المدورة الصغيرة Teres Minor**: وتقوم **بالدوران الوحشي**.

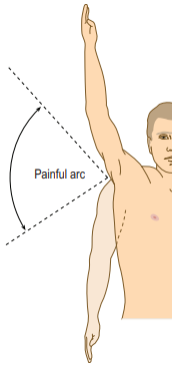
RB Clinical ملاحظات سريرية:

- ترتكز جميع هذه العضلات على أحدوبتَي العضد، فإذا التهبت تصبح مؤلمة أثناء التبعيد.
- يمكن أن يلتهب وتر العضلة فوق الشوكية **لوحده**، أما باقي العضلات **فنادراً ما تلتهب لوحدها** حيث أنها غالباً ما تكون جزءاً من إصابة الكم الوتري.
- يكون وتر العضلة فوق الشوكية مسؤولاً عن أول 45 درجة في حركة التبعيد، ومن ثمّ الدالية حتى الوصول لـ 90 درجة، ومن ثم شبه المنحرفة حتى الوصول للأعلى.
- **القوس المؤلمة**: التهاب العضلة فوق الشوك (التي تقوم بحركة تبعيد الكتف حتى الزاوية 45)[11] وهو سهل نظرياً صعب عملياً.
- المشكلة أن الألم في هذه الحالة مبرح وبشدة لذا المريض لا يستطيع إكمال التبعيد حتى الزاوية 120 ليزول الألم بعدها من شدة الألم.



[11] أيضا ذكر مرجع Macleod أن العضلة فوق الشوكية مسؤولة عن التبعيد من 0 - 15 درجة، والألياف المتوسطة من العضلة الدالية مسؤولة عن التبعيد من 15 - 90 درجة.

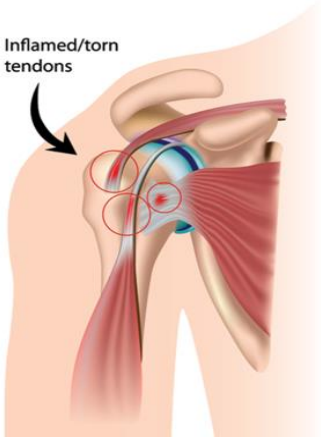
إصابات الكم الوتري



- وفيها تتحدد حركة التبعيد في قسمها الأوسط (بين 45 حتى 135 درجة)، أي أنّ الألم لا يحدث فوراً وإنما من الدرجة 45 حتى 135 ويحدث ما يسمى **القوس المؤلمة**[12] (وهي التظاهر السريري الأبرز لهذه الإصابة) نتيجة التهاب مثلاً أو انحشار الكم الوتري، وإذا استطاع المريض أن يتجاوز القوس المؤلمة ويصل إلى الأعلى (فوق 135 درجة) يزول الألم ولكن غالباً يكون الألم شديداً ولا يستطيع إكمال الحركة.
- وفي بعض الحالات كتمزق الوتر والآفات العصبية يمكن أن تؤدي إلى ضعف غير مؤلم.
- **بشكل عام**: نقوم بفحص الإصابات الوتريّة عن طريق ملاحظة تحدد مؤلم في الحركة التي يكون الوتر المصاب مسؤولاً عنها.

RBO Clinical — حالات سريريّة:

Torn Rotator Cuff



- كان مريض يعاني من آفة وترية يتألّم بشدة وفجأة زال الألم، إلى ماذا يشير ذلك؟
- هنا يجب فحص الوظيفة لأنه إذا زال الألم وزالت الوظيفة فهذا يعني أن الوتر قد انقطع.
- طُلب من مريض لديه ألم في الناحية الكتفية أن يقوم بتبعيد ذراعه وكان هناك ألم بمقاومة التبعيد، ماذا تستنتج؟
- نستنتج أن المريض لديه آفة وترية بالوتر فوق الشوكي.

في حال كانت الشكاية ليست كتفية، نفحص الكتف بجعل المريض يقوم بحركتين مركبتين على الشكل الآتي:

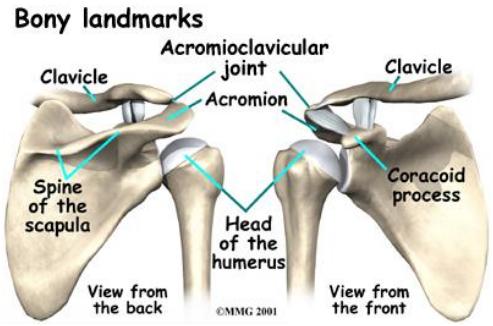
راحة اليد خلف الرقبة	ظهر اليد بين لوحي الكتف
• بسط. • تبعيد. • دوران خارجي.	• عطف. • تقريب. • دوران داخلي.

- في حال وجود مشكلة عند الفحص السابق نقوم بحركات أدق حتى نعرف مكان المشكلة.

[12] يوجد اختلاف بين المراجع في درجة القوس المؤلمة فهي شائعة بين 90 و120 درجة وقد تكون بين 45 و130 درجة ووردت في مرجع Macleod أنها من 60 حتى 120 درجة، وقد ذكرها الدكتور هذه السنة أنها من 45 إلى 120 درجة.

مفاصل أُخرى

المفصل الأخرمي الترقوي Acromioclavicular joint



- الأخرم مهم لأنه نقطة ارتكاز للعديد من أوتار العضلات في منطقة الكتف.
- **المفصل الأخرمي الترقوي** هو تمفصل الترقوة مع **الناحية الإنسية** للنتوء الأخرمي.
- يتضخم عند **كبار السن**.
- تحدِث إصابته ألماً **بتقريب الذراع** **أمام الصدر** فهو يساهم في حركة التقريب.
- يصاب كغيره من المفاصل **بالداء الرثياني** والرضوض.

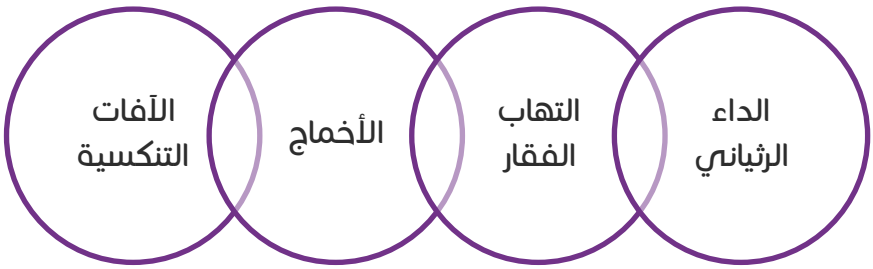




طريقة فحص المفصل الأخرمي الترقوي عبر الجس

المفصل القصي الترقوي Sternoclavicular joint

- يقع بين النهاية الإنسية للترقوة وجانب القص.
- هو مفصل سطحي تظهر فيه **العلامات الالتهابية بوضوح**.
- يمكن أن يصاب الشخص السوي عادة بالتهاب المفصل القيحي في الركبة أو الورك، أما **مدمنو المخدرات** (وهم أكثر الأشخاص عرضة للإنتانات) والمصابون **بالعصيات الزرق** فيصابون **بالتهاب المفصل القيحي** في أماكن غير شائعة مثل **المفصل العجزي الحرقفي** و**المفصل القصي الترقوي**.
- يمكن أن يصاب هذا المفصل بِـ:



إن وجود احمرار شديد بالمفصل القصي الترقوي نادراً ما يشير إلى التهاب إنتاني، لذلك نرفع يدا المريض للأعلى لمدة دقيقتين فإذا شعر بوخز يكون السبب **تعاطي المخدرات** حيث أن الالتهاب الإنتاني بمفصل غير نموذجي وبالمفصل الفكي الصدغي يحدث بسبب تعاطي المخدرات أو قد يكون بسبب نقص المناعة.

التهاب المفصل القيحي: RBC Clinical

- عادةً لا يصيب المفصل الأخرمي الترقوي أو القصي الترقوي فهو غير شائع فيهما ولكن تزيد خطورة الإصابة بهما عند الذين يتعاطون المخدرات.
- الشائع في هذين المفصلين هما **الداء الرثياني** و**الداء التنكسي** البدئي وهما سهلا التأمل.

المفصل الفكي الصدغي Temporomandibular joint

التأمل:

- يُفتّش عن التورم أمام الأذن عند فتح وإغلاق الفم.
- وجود الاحمرار يشير إلى التهاب هذا المفصل.

الجس:



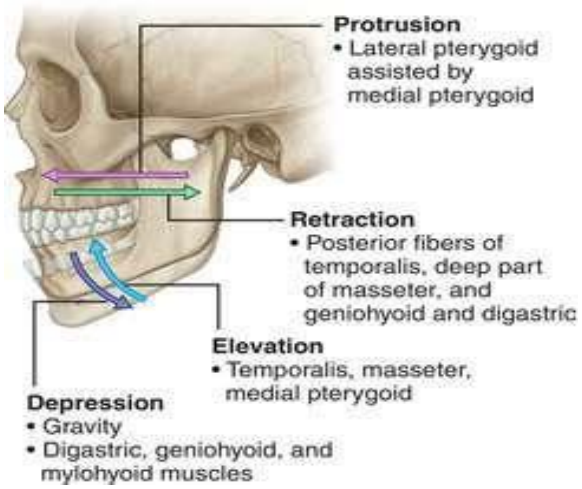
- يجس المفصل بوضع الإصبع أمام الأذن بينما يقوم المريض بفتح وإغلاق الفم.
- يُجس رأس الفك السفلي وهو ينزلق نحو الأمام عندما يفتح الفم وقد يشعر الفاحص بالاحتكاك أو بصوت طقطقة.
- كما يحدث الإيلام في حالة التهاب المفصل (الداء الرثياني).
- إذا لم يتم إصلاح سوء الإطباق الفكي عند بعض المرضى يمكن أن يؤهب ذلك إلى داء تنكسي بادئ.

حركات المفصل:

✓ بما أنَّ المفصل الصدغي الفكي مفصل لقيمي، فإن له حركات خاصة:

تحريك الفم إلى الأمام والخلف	تحريك الفك إلى الأعلى والأسفل	حركات جانبية

✓ **ومن فحوصاته**: يجب أن يستطيع الشخص أن يدخل **ثلاثة أصابع متوضعة طولياً** في فمه، وإذا لم يستطع نستنتج وجود مشكلة في المفصل.



اختبر نفسك

1	في عضلات الكم المدور: (الخاطئة)	الجواب
	A. العضلة المدورة الصغيرة مسؤولة عن الدوران الوحشي. B. العضلة تحت الشوك مسؤولة عن التقريب. C. العضلة تحت الكتف مسؤولة عن الدوران الإنسي. D. العضلة فوق الشوك مسؤولة عن التبعيد.	B
2	التشوهات المفصلية ما عدا:	
	A. الانحراف الزندي في التهاب المفاصل الرثياني. B. عقد هيبردن على جانبي السلاميات القاصية. C. الأصابع النقانقية في الداء الرثياني.	C

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية محاضرتنا

لا تنسونا من صالح الدعاء



دوّن ملاحظاتك